

6-2. 배변이상(설사)

• 중요 포인트

- 1. 감염성 vs. 비감염성 / 기능성 vs. 기질성 원인 감별
- 2. 설사량이 많은 경우 탈수로 인한 응급 상황이 생길 수 있음을 교육 – 탈수 정도 평가 및 수액 공급 고려
- 3. 혈변, 심한 체중감소 동반 시 대장내시경의 필요성 설명

•

• 평가 목표

원인		
급성	급성 감염성 설사	식중독/급성 위장염
	급성 비감염성 설사	허혈성결장염, 약물(항생제, 삼투성 하제), 젖당불내성
만성	만성 기능성 설사	과민성 대장 증후군(IBS)
	만성 염증성 설사	염증성 장질환(IBD)
전신질환에 의한 설사		내분비질환(갑상샘기능항진증), 카르시노이드 등의 악성종양
평가목표		
1) 설사의 원인(감염성, 기능성 등)을 감별하기 위한 병력청취와 신체진찰을 시행		
2) 설사와 관련된 수분, 전해질 이상에 대한 치료계획을 수립		
구체적인 성과		
병력 청취	설사 양상(기간, 특징 등) 평가	[기간] 급성 < 2 주 / 아급성 2~4 주 / 만성 4 주 (소아는 3 주) [특징] 양: 200g/일 이상 빈도: 3 회/일 초과 성상: 물처럼(수양성-장염, 식중독) / 끈적끈적(점액성-IBS, IBD) / 기름 떠 있음(지방변-흡수장애) 냄새 [염증성 vs. 비염증성 설사] 염증성: 고열($\geq 38.5^{\circ}\text{C}$), 혈변, 대변 내 WBC / 경험적 항생제 고려 S. aureus, B. cereus, V. cholerae / 노로바이러스, 로타바이러스(소아) 비염증성: 발열 없거나 미열, 수양성 설사 / 보존적 치료 EHEC(햄버거), Shigella(닭고기, 뒤무직), Salmonella(계란), C. difficile(항생제) [기능성 vs. 기질성] 기능성: 대개 소량, 수면장애 없음, 장외 증상(-), 스트레스 관련성 ↑ 기질성: 대개 대량, 수면장애 동반 가능, 장외 증상 가능, 동반증상(체중감소, 혈변, 복통)
	설사 원인 감별	[급성 설사] 1. 감염성 설사 – 식중독, 급성 위장염 1) 염증성/비염증성 구분: 발열, 혈변 유무 2) 음식 섭취력: 1~8 시간 내 비염증성 설사 – S. aureus, B.cereus 식중독 3) 여행력: 인도, 동남아시아 등. 쌀뜨물 설사 – Vibrio cholerae / 염증성 – Salmonella, Shigella 4) 항생제 복용력: C.difficile 에 의한 거짓막대장염 2. 비감염성 설사 – 약물(항생제, 하제 남용 등), 허혈성 대장염(고령, 혈성 설사, 급성 하복부통) [만성 설사] 1. 기능성 – 과민성 대장 증후군, 젖당불내성 2. 기질성 – 염증성 장질환, 흡수장애(단장증후군, 만성체장염, 소장내세균과증식 등), 종양, 갑상샘기능저하증

	동반 증상과 위험 요인 평가		[동반증상] 탈수: 두근거림, 호흡곤란, 어지러움, 소변량 감소 식중독/급성위장염: 구토, 복통, 발열, 탈수 허혈성대장염: 급성 복통, 혈변 과민성대장증후군: 복부팽만, 배변 후 호전, 점액질 변, 잦은 트림/방귀, 소화불량 젖당불내성: 우유 마시면 속 불편 염증성장질환: 혈변, 심한 복통, 탈수, 체중감소 흡수장애: 지방변 종양: 체중감소, 혈변, 변비 동반 가능 갑상샘기능저하증: 더위불내성, 체중감소, 두근거림 [위험요인] 최근 먹은 음식(평소 안 먹던 음식), 우유, 여행, 스트레스, 약제(항생제, 제산제, 하제)	
신체진찰	탈수 정도 확인		V/S 확인, 결막 확인(빈혈), 구강(탈수) 피부 긴장도	
	원인 감별		목: 갑상샘 촉진, 경부 림프절 촉진(암, 감염성 질환) 복부: 시, 청(5 구역 3 초간), 타, 촉(종괴 여부) DRE: 혈변, 종괴, 치핵 여부 확인	
진단 및 치료	원인 질환 감별	기능성	갑상샘항진증: TFT IBS: 대변검사, 대장내시경, 혈액검사 젖당불내성: 수소날숨검사, 젖당부하검사	갑기항: methimazole IBS: 안정, 운동, 식습관교정, 진경제 젖당: 유당회피
		기질성	식중독/급성위장염: 대변검사, 대변배양검사 염증성장질환: 대장내시경, 복부 CT 결장암/직장암: 대장내시경, 복부 CT 허혈결장염: 대장내시경, 복부 X-ray	감염: 수액, 항생제(일부) IBD: 설파살라진, 스테로이드 종양: 수술, 항암, 방사선치료 허혈: 수액, 금식, 항생제(중증), 수술
	탈수 및 전해질 이상 교정		병력청취/신체진찰 상 탈수 의심 시 병원에서 수액 공급하여 수분, 전해질 보충	
	전문적 치료가 필요한 환자 선정		기질적 질환 의심되는 경우 (혈변, 심한 체중 감소 등) 대장내시경의 필요성 설명 [Red flag sign -> 대장내시경 검사 필요] 1. 50 세 이상 2. 위장관 출혈(혈변, 흑색변, 철결핍성 빈혈) 3. 체중감소 4. 대장암 가족력 5. 아주 많은 양의 설사	
환자 교육	탈수 및 전해질 이상 교정의 필요성		우리 몸은 항상성을 유지하기 위해 수분을 일정하게 조절하는데, 체내 수분이 부족해지는 경우를 탈수라고 함. 탈수가 발생하면 어지러움, 입 마름, 소변량 감소와 같은 증상이 나타날 수 있으며, 심한 경우 의식저하 등 위험한 상황으로 이어질 수 있음. 병원에서 정맥주사로 수액 공급하여 손실된 수분과 전해질을 보충할 것.	

● 원인 질환 정리

질환			병력청취	질환 설명	신체진찰	검사	치료
급성	감염	식중독/급성위장	음식 섭취 후 구토, 복통,	세균이나 바이러스, 독소가 들어있는	복부 압통, 탈수 소견	대변검사, 대변배양검사,	수액공급, 금식 염증성인 경우 항생제

	성	염	발열, 탈수, 설사 함께 먹은 사람도 증상	음식을 먹고 발생한 감염질환			
	비 감 염 성	허혈성 대장염	갑작스러운 복통, 혈변, 고령	대장으로 가는 혈류가 감소해서 대장조직의 염증/괴사가 일어나는 질환	복부 압통	대장내시경, 혈액검사, 복부 X-ray	수액공급, 음식
		약물 유발 설사 1	Hx. 항생제, 제산제, 하제(변비약) 남용			대변검사, 대변 C.difficile 독소검사	약물 중단 (거짓막대장염-중단 후 metronidazole/vancomycin)
만 성	기 능 성	과민대장 증후군(I BS) 1+1	복통-배변 후 복통 호전 복부팽만, 변비-설사 반복, 점액질 변, 소화불량, 방귀트림	검사상 특별한 이상은 없지만 식사나 가벼운 스트레스 후 복통, 복부 팽만, 변비, 설사 같은 소화기 증상이 반복되는 질환	경미한 복통 (배변 후 호전)	대변검사, 혈액검사, 대장내시경	심리적 안정 스트레스 줄이기 식습관 교정 적당한 운동
		젖당불내 성	우유 마시면 속 불편, 묽은 변	우유 등 유제품에 들어있는 유당을 분해하는 효소(lactase)가 부족해 유당이 소화되지 않는 질환		수소날숨검사(유당 이 발효되어 폐로 배출), 경구 유당부하검사(일정 량 유당 섭취 후 혈액 내 혈당 증가)	유당이 든 음식 피하기
	기 질 성	결장암/ 직장암	[전신] 체중감소, 피로 [소화기] 혈변, 대변 가늘어짐	대장(결장/직장)에 생긴 종양	[DRE] 종괴, 혈변	대장내시경, 복부 CT	수술, 항암, 방사선치료
		갑상샘기 능항진증 1+1	더위불내성, 체중감소, 두근거림	갑상샘이 갑상샘호르몬을 너무 많이 분비함	갑상샘 비대	갑상샘기능검사	methimazole
		단장증후 군	장절제 과거력	소장이 짧아 영양소의 소화흡수 기능이 떨어진 것		복부초음파, X-ray	완전정맥영양, 지사제, cholestyramine
		염증성 장질환 1(크론)	면역체계의 잘못된 공격으로 위장관의 만성 염증	설사, 체중감소, 복통, 발열	복부 압통 (없을 수 있음) DRE 상 혈변	대장내시경 염증수치	약물 (중증도에 따라 다양한 약물로 급한 염증을 가라앉히고 유지 치료를 진행)

O	언제부터 갑자기/계속	cf. 급성(<2 주): 감염(식중독/급성위장염), 허혈성대장염, 약물 만성(>4 주): 과민성대장증후군, 젖당불내성, 결장/직장암, 갑상샘기능항진증
L		
D	하루에 변 몇 번	설사: 하루 200g 이상의 묽은 변, 배변 횟수가 하루 3회 초과
Co	심해지나요	
Ex	이전에도-> 지사제 복용? 얼마나 오래? 효과?	
C	[양상] 양(평소량 비교) / 냄새(지방변/흡수장애 악취, 세균성 감염) / 색(피 섞여있는지) / 성상(물처럼/끈적끈적/기름 떠있음) 분출성 [일상] 일상생활 지장 [많이 힘들것 같아요]	
A	[OPEN] 다른 불편한 곳은 없으세요?	
	전신	발열/오한/피로/체중변화(증가/감소) r/o 감염, 암
	탈수	두근거림/호흡곤란/어지러움/소변량감소/근육경련
	소화기	식욕저하/구역, 구토/변비/흑색변, 혈변(피의 양) 복통(양상, 배변 후 호전)/복부팽만 r/o IBS 뒤무직(배변 후 변이 남은 느낌) r/o Shigellosis, tumor 변실금(본인 의지와 관계없이 속옷에 대변이 묻어있음)
	항문	항문통증
	갑상샘	더위불내성
	정신	우울/스트레스/불안
F	악화/완화 요인 스트레스, 식사와의 관련성 - IBS 최근 먹은 음식 (언제, 어떤 음식) / 평소 안 먹던 것 먹었는지 / 같이 먹은 사람도 증상 있는지 - 식중독 우유 - 젖당불내성 최근 여행 - V. cholerae, Shigella, Salmonella	
E	건강검진+위내시경/대장내시경 - 결과	
외	복부 외상/수술	
과	HTN/DM/결핵/간 소화기질환 만성질환 조절	
약	약물 (항생제/제산제/삼투성 하제)	
사	술/담배/커피/직업/식습관(자극적인 음식, 식이섭유/채소, 물)/운동/스트레스	
가	대장암/설사	
여	규칙적/LMP/통증/양/임신가능성	
PEx	동의 구하기 손 씻기	
	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈: 빈혈 2 입: 탈수 3 목: 갑상샘 촉진, 경부 림프절 r/o 암 4 사지: 피부 긴장도, 오목부종
	복부	복부: 시(외상/수술 흔적, 팽만)-청 (1 군데 당 3-5 초)-타 (먼 곳부터)-촉(먼 곳부터) **환자 수치실이 들지 않도록 잘 설명, 가려주기
	DRE	손씻기+환자 확인 안내 설사의 원인을 알아보기 위해 항문직장검사 시행하겠습니다 항문에 손가락 넣어서 항문, 직장의 종양, 혈변 (+전립선) 확인하기 위한 검사 불편함 자세 나 등지고 누워+왼다리는 그냥 피고+오른다리는 가슴에 볼도록 90도 구부리고 새우등 자세+엉덩이는 최대한 뒤로 빼서 새우등자세 PPI 옷 내리세요+불필요한 부분은 가려드리겠습니다 안보여서 불안하겠지만 모든 과정 말로 설명하고 진행할테니 걱정 안하셔도 됩니다 시진 항문주변- 덩이 생길 চে양 염증 없음+변보듯 힘주세요 촉진 항문주위 만져볼게요-덩이/압통 손가락 손가락 넣어 진찰할 것- 쎄 차갑고 불편함 => 변참을때처럼 힘주고 힘빼기 뻘 때 빼겠습니다 하기+끝났습니다 고생많으셨습니다+여분 휴지 마무리 변색성상+ 병변: 항문직장선 기준 *cm 상방+*cm 크기+*시 방향 등근모양+매끄러움/울퉁불퉁경계+고점/유동+압통

	협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기		
	기본!!	혈액검사(CBC, 전해질) 대변검사(대변 WBC, 배양) 영상검사(복부 X-ray, CT) 대장내시경	탈수 → 수액공급 및 전해질 교정 꼭 필요시 지사제 (loperamide - 대장 운동 억제, 신속한 효과, 복통 감소 but 발열, 혈변 동반 시 악화 위험)
	감염	혈액검사, 대변검사	수액, 음식, 항생제(염증성 설사) / 지사제 금기
	감염생기능항진증	감염생기능검사	약물치료(Methimazole)
	결장/직장암	대장내시경, 복부 CT	검사 후 병기에 따른 치료 - 수술/항암/방사선
	단장증후군	복부 X-ray, 초음파	완전정맥영양, 지사제, cholestyramine
	염증성 장질환	대장내시경, 혈액검사, 복부영상검사	입원, sulfasalazine, 스테로이드, 필요시 수술
	거짓막대장염	혈액검사, 대변검사(독소),	항생제 중단 후 vancomycin/metronidazole
	젖당불내성	수소호기검사, 젖당부하검사	유당 회피
교육	[그동안 설사 때문에 많이 고생하셨을 것 같습니다. 지금부터 치료를 잘 받으시면 호전되실 수 있습니다. 일찍 병원에 잘 오셨습니다.] [탈수/전해질 교정] 우리 몸은 항상성을 유지하기 위해 수분을 일정하게 조절하는데, 체내 수분이 부족해지는 경우를 탈수라고 함. 탈수가 발생하면 어지러움, 입 마름 같은 증상이 나타날 수 있으며, 심한 경우 의식저하 등 위험한 상황으로 이어질 수 있음. 또한 전해질 이상으로 인해 근육 경련, 팔다리 힘빠짐, 의식저하 등이 발생할 수 있어 병원에서 정맥주사로 수액 공급하여 손실된 수분과 전해질을 보충할 것. [응급] 1. 집에 가셔도 설사하다가 어지러움, 두근거림, 숨 쉬기 힘든 증상이 있거나 입 안이 마르면 탈수 증상이 심하다는 뜻이므로 바로 병원에 오셔서 수액 치료를 받아야 함. 2. 고열, 혈변, 복통이 너무 심한 경우도 병원에 바로 내원 [지사제 남용 자제] 지사제를 너무 자주 장기간 복용하면 장 운동을 느리게 만들고 변비가 생길 수 있어 꼭 필요한 경우에만 사용 [생활습관 개선] 식사: 기름진 음식, 맵고 짠 음식, 카페인 등은 장을 자극할 수 있으므로 피하기 금주: 알코올은 음식물을 빠르게 지나가게 해 설사를 유발하므로 피하는 게 좋음. [젖당불내성] 우유 등 유제품 섭취 자제. 우유 대신 두유나 아몬드유 같은 대체 식품 먹기 [식중독/급성위장염] 음식은 상하지 않도록 냉장고에 보관하고 조리 후 빨리 섭취하기. 더울 때 날 것은 되도록 먹지 말고 제대로 데워 먹기. 요리하거나 음식 먹기 전에 반드시 손 씻기 [국가암검진] 대장암은 만 50 세 이상 남녀 대상 매년 분변 잠혈검사를 시행 (이상 시 대장내시경 검사)		
PPI	궁금하신 점 있으실까요?		